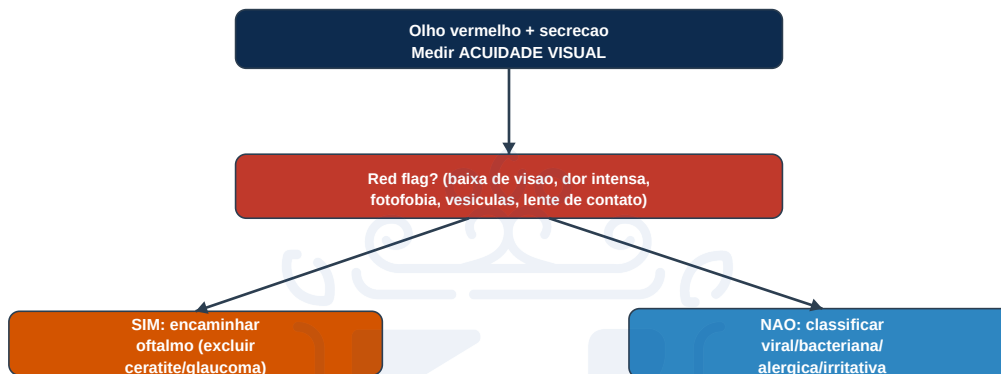


CONJUNTIVITE — DIFERENCIAR E RED FLAGS

FLUXOGRAMA — OLHO VERMELHO

CONJUNTIVITE — ANTES, EXCLUIR O GRAVE



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Inflamação/infecção da conjuntiva (membrana que reveste esclera anterior e interior das pálpebras)
- Caracteriza-se por hiperemia, edema e secreção ocular
- Classificação: infecciosa (viral, bacteriana) ou não infecciosa (alérgica, irritativa)
- Diagnóstico é predominantemente CLÍNICO (história + exame)

DIFERENCIAÇÃO DAS ETIOLOGIAS

Tipo	Sintoma-chave / lateralidade	Secreção e achados
Viral	Bilateral, contato com doente; pode ter faringite	Aquosa; folículos; linfadenopatia pré-auricular (adenovírus)
Bacteriana	Unilateral no início, pálpebras grudadas ao acordar	Mucopurulenta/purulenta; hiperemia difusa, sem prurido
Alérgica	Bilateral; PRURIDO INTENSO; atopia	Aquosa/mucoide clara; papilas tarsais
Irritativa/tóxica	Exposição química/ambiental	Hiperemia, lacrimejamento; sem secreção purulenta

RED FLAGS — NÃO É 'SÓ CONJUNTIVITE'

ENCAMINHAR / EXCLUIR DIAGNÓSTICO GRAVE

- Diminuição da acuidade visual (qualquer grau)
- Dor ocular moderada/intensa (não apenas 'areia') ou fotofobia importante
- Vesículas em pálpebras ou nariz (herpes/zóster) ou sinais de envolvimento corneano
- Secreção hiperaguda/purulenta intensa (suspeita de gonococo) ou conjuntivite neonatal
- Uso de lente de contato (risco de ceratite por Pseudomonas), imunossupressão, trauma/cirurgia recente
- Náuseas/vômitos com olho vermelho e dor -> pensar GLAUCOMA AGUDO

EXAME E QUANDO INVESTIGAR

AValiação

- SEMPRE medir acuidade visual; inspecionar hiperemia, tipo de secreção, edema palpebral
- Pesquisar linfadenopatia pré-auricular (viral); fluoresceína se suspeita de lesão corneana
- Exames complementares só em casos específicos: neonatal (cultura), gonocócica/clamidal, herpes com córnea
- Casos graves/recorrentes/crônicos/refratários: cultura, citologia, avaliação oftalmológica

TRATAMENTO — VIRAL E BACTERIANA

Rx VIRAL (autolimitada 7-14 dias)

Lágrimas artificiais (carmelose 0,5%) 1-2 gotas 4-6x/dia
Compressas frias 3-4x/dia por 10-15 min
Anti-histamínico tópico opcional (olopatadina 0,1% 12/12h)
Higiene rigorosa: não compartilhar toalhas; lavar as mãos
NÃO é necessário antibiótico

Rx BACTERIANA não complicada

Tobramicina 0,3% colírio 1-2 gotas 6/6h por 7-10 dias
OU Ciprofloxacino 0,3% colírio 6/6h por 7 dias
Usuário de lente de contato: cobrir *Pseudomonas* -> quinolona + avaliar oftalmo
Limpeza das secreções com SF (gaze separada por olho)

TRATAMENTO — ALÉRGICA E IRRITATIVA

Rx PRESCRIÇÃO

ALÉRGICA: Cetotifeno 0,025% colírio (anti-H1 + estabilizador de mastócito) 1 gota 12/12h
+ anti-histamínico oral se necessário (loratadina 10mg/dia); afastar o alérgeno
IRRITATIVA/TÓXICA: identificar e remover o agente; lavar com SF abundante se exposição química
+ lágrimas artificiais 4-6x/dia + compressas frias
Entre dois colírios diferentes, aguardar 5-10 min; nunca encostar o bico no olho

CHECKLIST DE ALTA

ANTES DE LIBERAR

- ☐ Acuidade visual preservada e reflexos pupilares normais
- ☐ Córnea íntegra (sem opacidade/úlceras/hipópio) e motilidade ocular sem dor
- ☐ Ausência de dor intensa, fotofobia incapacitante ou náuseas/vômitos (afasta glaucoma agudo)
- ☐ Sem trauma/perfuração/queimadura química grave; não imunossuprimido grave
- ☐ Etiologia definida + capacidade de aplicar colírios + plano de retorno e afastamento (se infecciosa)

ORIENTAÇÕES E SINAIS DE ALERTA

RETORNAR IMEDIATAMENTE SE

- Visão ficar muito embaçada
- Dor forte no olho (não apenas 'areia/ardência')
- Sensibilidade à luz insuportável ou secreção purulenta intensa
- Suspender lentes de contato até cura total; não coçar; não compartilhar toalhas/maquiagem

MODELO DE ENCAMINHAMENTO — OFTALMO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Olho vermelho há ____ dias com sinais de alarme: ____ (baixa de AV / dor intensa / fotofobia / suspeita de ceratite).
- Acuidade visual: OD ____ / OE _____. Lavagem ocular realizada: sim/não.
- Conduta na unidade: _____. Solicito avaliação oftalmológica para excluir glaucoma agudo, uveíte ou úlcera de córnea.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com olho vermelho, dor ocular intensa, fotofobia, náuseas e visão embaçada. Qual a conduta mais adequada?

- A) Prescrever colírio antibiótico e alta como conjuntivite bacteriana
- B) Tranquilizar e dar alta, pois é conjuntivite viral
- C) Considerar diagnóstico grave (ex.: glaucoma agudo) e encaminhar com urgência ao oftalmologista
- D) Prescrever corticoide tópico e alta
- E) Apenas compressas frias

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado é mais característico da conjuntivite alérgica?

- A) Secreção purulenta unilateral
- B) Prurido intenso bilateral com papilas tarsais
- C) Linfadenopatia pré-auricular
- D) Pálpebras grudadas ao acordar
- E) Hipópio

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Paciente usuário de lentes de contato com olho vermelho, dor e secreção. Qual a principal preocupação?

- A) Conjuntivite alérgica sazonal
- B) Ceratite infecciosa (risco de *Pseudomonas*) — encaminhar/avaliar oftalmo
- C) Conjuntivite viral autolimitada
- D) Pterígio
- E) Episclerite benigna

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Conjuntivite bilateral, secreção aquosa, folículos e linfadenopatia pré-auricular, com história de contato. Etiologia e tratamento?

- A) Bacteriana — antibiótico tópico
- B) Viral (adenovírus) — medidas de suporte e higiene; geralmente sem antibiótico
- C) Alérgica — corticoide sistêmico
- D) Fúngica — antifúngico tópico
- E) Gonocócica — ceftriaxona IM

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre os exames complementares na conjuntivite, é correto:

- A) São obrigatórios em todos os casos
- B) O diagnóstico é predominantemente clínico; exames ficam para casos específicos (neonatal, gonocócica/clamidal, grave/refratário)
- C) Sempre exigem cultura de secreção
- D) A sorologia viral é mandatória
- E) A biópsia conjuntival é rotina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Olho vermelho com dor intensa, fotofobia, baixa de visão e náuseas/vômitos NÃO é conjuntivite banal — sugere glaucoma agudo de ângulo fechado (ou uveíte/ceratite). É emergência: encaminhar ao oftalmologista.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O prurido intenso bilateral com papilas na conjuntiva tarsal é o marcador da conjuntivite alérgica, frequentemente com atopia associada. Secreção purulenta/pálpebras grudadas = bacteriana; linfadenopatia = viral.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Em usuário de lente de contato, olho vermelho doloroso obriga a afastar ceratite infecciosa, especialmente por *Pseudomonas* — potencialmente cegante. Suspender a lente e garantir avaliação oftalmológica.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Bilateral, secreção aquosa, folículos e linfadenopatia pré-auricular após contato = conjuntivite viral por adenovírus. Tratamento é de suporte (lágrimas, compressas, higiene); antibiótico não é necessário.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O diagnóstico de conjuntivite é clínico. Exames complementares (cultura, citologia, testes específicos) reservam-se a situações como neonatal, suspeita de gonococo/clamídia, herpes com córnea, e casos graves/refratários.

SM24
Suporte ao Plantão Médico